Въведение в медицинската етика

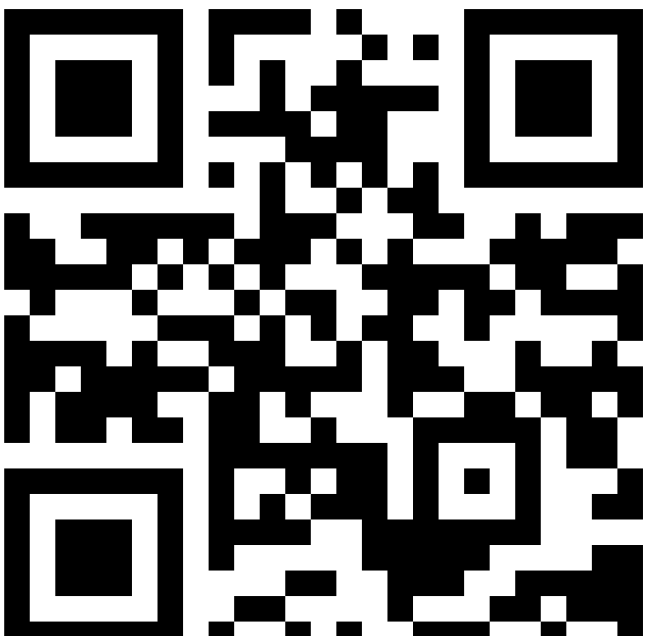
Морал, право и деонтология · етични теории · принципи · кодекси · българската нормативна рамка · анализ на казус

Упражнение 1 · Социална медицина и медицинска етика I · 2026/2027

гл. ас. д-р Костадин Костадинов, д.м.

Катедра „Социална медицина и обществено здраве“ · Медицински университет – Пловдив

Регистрация



Курсът и как да работим в него

Формат

- 7 упражнения по медицинска етика по 90 минути и лекции
- лекционен преподавател: проф. д-р Нина Мусурлиева, д.м.
- 2 колоквиума с бонус точки; изпит през януари и поправка
- държавен изпит по социална медицина и медицинска етика, VI курс

Материали

- конспект за семестриалния изпит
- компендиум за държавния изпит
- сайт на преподавателя: презентации, 15-минутни четива, учебни задачи с примерни отговори
- учебник по медицинска етика (книжарницата на МУ)

Всяко упражнение следва една логика: етичният проблем → аргументите → българската правна норма → казус, който решавате и обосновавате.

Цели на упражнението

След упражнението трябва да можете:

1. да разграничавате **морал, етика, право и деонтология** и да обясните защо законосъобразното действие може да е неетично;
2. да прилагате **четири етични теории** — консеквенциализъм, деонтология, етика на добродетелите, етика на грижата — към един и същ клиничен проблем;
3. да определите **четирите принципа** на биомедицинската етика, да обясните **конкретизирането и претеглянето** им и основните критики към принципализма;
4. да проследите линията **Хипократова клетва → Пърсивал → Нюрнберг → Женева → Хелзинки → Овиедо** и какво добавя всеки документ;
5. да посочите **българските източници**, които обвързват лекаря — Конституция, ратифицирани договори, Закон за здравето, ЗСОЛЛДМ, Кодекс за професионална етика — и кой следи за спазването им;
6. да анализирате кратък казус по **структуриран метод** и да защитите решение.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. **Морал, етика, право и деонтология**
2. Етични теории
3. Принципализъм и критиките му
4. От Хипократ до Овиедо
5. Българската нормативна рамка
6. Как да анализираме етичен казус

Моралът и етиката не са едно и също

Морал — съвкупност от убеждения, правила и ценности, с които една общност преценява поведението като правилно или неправилно. Усвоява се в семейството, културата и религията и има **ценностно-ориентираща, регулативна и възпитателна** функция.

Етика — **систематична, критична рефлексия** върху морала: пита кои норми са обосновани и защо.

Ниво	**Въпрос**
Дескриптивна етика	Какво всъщност мислят и правят лекарите и пациентите? (емпирично)
Нормативна етика	Какво **трябва** да се направи и на какво основание?
Приложна етика	Какво следва за конкретна област — медицина, изследвания, обществено здраве?
Метаетика	Какво означават „добро“, „правилно“, „дълг“; могат ли моралните твърдения да са истинни?

Медицинската етика е нормативна и приложна: тя трябва да завърши с обосновано решение, а не само с описание на мнения.

Етика и право: припокриват се, но не съвпадат

	Право	Етика
Източник	държавна власт: парламент, правителство, съдилища	обосновани аргументи, съвест, професионална общност
Форма	писано, обнародвано, йерархично подредено	писано (кодекси) и неписано
Санкция	държавна принуда: глоба, лишаване от свобода, обезщетение, отнемане на право да практикува	морално осъждане; съсловна санкция, когато е кодифицирано
Обхват	една юрисдикция, в определен момент	претендира за обща валидност
Стандарт	изисквания, които могат да бъдат принудително наложени	може да подкрепя, надхвърля или критикува правото

Законно, но етически съмнително

Лекар приема щедро платено участие в „консултативен съвет“ на фармацевтична компания почти без реална работа и го декларира според формалните правила, а после предписва нейния продукт.

Закон, който е бил етически погрешен

Евгеничните закони за стерилизация през XX век (напр. Buck v. Bell, САЩ, 1927) показват, че законността не гарантира морална допустимост.

Деонтология: две значения на една дума

Медицинска деонтология — професионален дълг

От гр. **deon** (дълг) и **logos**. Терминът е използван от Дж. Бентам (**Деонтология, или наука за морала**, 1834). В централно- и източноевропейската традиция **медицинската деонтология** е учението за професионалните задължения на лекаря: поведение към пациенти, колеги и общество, медицинска тайна, колегиалност, компетентност.

Деонтологична етика — морална теория

Група теории (Кант, У. Д. Рос), според които правилността на действието зависи от **задължения и права**, а не само от последиците. Някои действия — измама, използване на човека само като средство — са неправилни дори когато биха довели до добър резултат.

Медицинска етика	Биоетика	Медицинска деонтология	Медицинско право
морални проблеми на клиничната практика, с център отношението лекар–пациент	етика на медицината **и** науките за живота, изследванията, технологиите, околната среда, политиката	учение за професионалните задължения на лекаря — отчасти кодифицирани	задължителни правни норми за здравеопазването, правата и отговорността

Биоетика: ново име за стари въпроси

- **1927** — Фриц Яр използва **Bio-Ethik** за нравственото отношение към хората, животните и растенията.
- **1970–1971** — Ван Ренселар Потър независимо въвежда **биоетика**; книгата **Bioethics: Bridge to the Future** (1971) призовава за мост между биологичното знание и човешките ценности.
- **70-те години** — изследователски скандали, разпределение на диализата, трансплантациите и интензивното лечение придават на биоетиката биомедицински фокус; областта става интердисциплинарна: медицина, философия, право, богословие, социални науки.

Днешният дневен ред

генетика и редактиране на генома · асистирана репродукция · трансплантация · край на живота · изследвания с хора · изкуствен интелект и данни · пандемии и обществено здраве · климат и здраве

Медицинската етика пита „какво трябва да направи този лекар за този пациент?“; биоетиката пита и „какво трябва обществото да позволи на медицината и науката?“

Пет вида „трябва“ в клиничното решение

Вид норма	Пример в България	Задължителна сила
Етичен аргумент	„Измамата на пациента нарушава уважението към личността“	силата на доводите
Правна норма	Закон за здравето, чл. 87, ал. 1: медицинските дейности се осъществяват след информирано съгласие	държавна санкция
Съсловна норма	Кодекс за професионална етика, чл. 26; правила за добра медицинска практика	санкция от БЛС въз основа на закон
Вътрешни правила	правилник на болницата за посещения, документация, бланки за съгласие	трудова дисциплина; трябва да съответстват на закона
Лично убеждение	религиозни или морални възгледи на отделния лекар	лична морална причина; не отменя професионалните и законовите задължения и не обвързва пациента

Доброто разсъждение назовава кой вид „трябва“ използва и проверява дали по-ниското ниво не противоречи на по-високото. **Етичният проблем** пита кое е правилно; **дилема** има, когато две морални изисквания не могат да бъдат изпълнени едновременно — и двете се разграничават от фактическата несигурност.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Морал, етика, право и деонтология
2. **Етични теории**
3. Принципализъм и критиките му
4. От Хипократ до Овиедо
5. Българската нормативна рамка
6. Как да анализираме етичен казус

Консеквенциализъм: действията се оценяват по последиците

Утилитаризъм (Дж. Бентам, 1789; Дж. С. Мил, 1861): правилно е действието, което води до **най-голямо общо благополучие**, като интересите на всеки се отчитат еднакво.

- утилитаризъм **на действието** — оценява се всяко отделно действие;
- утилитаризъм **на правилото** — следват се правилата, чието общо спазване дава най-добър резултат (напр. медицинската тайна се пази, дори когато еднократното ѝ нарушаване изглежда полезно).

В медицината: определяне на приоритети, анализ разходи–ефективност, ваксинационна политика, триаж.

Силни страни

безпристрастност; внимание към реалните ефекти; влиятелен подход в общественото здраве и разпределението на оскъдни ресурси

Слаби страни

може да оправдае жертването на индивида заради мнозинството; последиците са несигурни; **сумата** от ползата не казва **кой** носи тежестта

Деонтология: задължения, права и достойнство

И. Кант (1785) — категоричният императив

- **Всеобщ закон:** постъпвай само според максима, за която можеш да искаш да стане всеобщ закон.
- **Човекът като цел:** отнасяй се към всеки човек винаги като към цел и **никога само като към средство**.

За медицината: никаква измама „за доброто на пациента“; никакво използване на пациент за обучение или изследване без съгласие.

У. Д. Рос (1930) — prima facie задължения

Няколко независими задължения — вярност, поправяне на вреда, благодарност, справедливост, благодеяние, самоусъвършенстване, ненанасяне на вреда. Всяко е **prima facie** — задължаващо, но не абсолютно („на пръв поглед“): важи, **освен ако не бъде надделяно** от по-силно задължение в конкретната ситуация.

Силна страна

защитава индивида от жертване в името на общата полза; обосновава правата и информираното съгласие

Слаба страна

задълженията влизат в конфликт (истинност срещу предотвратяване на вреда), а строгите правила могат да пренебрегнат контекста

Етика на добродетелите и етика на грижата

Етика на добродетелите (Аристотел)

Пита **„какъв лекар трябва да бъда?“** Правилно е това, което би направил човек с добър характер и **практическа мъдрост** (*фронезис*). Лекарски добродетели: надеждност, съчувствие, честност, смелост, справедливост, благоразумие, почтеност.

Ограничение: дава малко конкретни насоки при нова дилема; „добрият лекар би знаел“ не е аргумент.

Етика на грижата (К. Гилиган, 1982; Н. Нодингс)

Моралът израства от **отношенията на зависимост** — внимание, отзивчивост, отговорност за уязвимите. Човекът се разглежда в семейството и общността си (**релационна автономност**).

Ограничение: риск от пристрастност към близките и от оправдаване на семейния патернализъм; справедливото разпределение на грижата изисква отделна обосновка.

Други подходи: **казуистика** — разсъждение от образцови случаи (Jonsen & Toulmin, 1988); **наративна етика** — житейската история на пациента придава смисъл на избора; **комунитаризъм** — общи блага и солидарност.

Един случай през четири теории

Ситуация

34-годишен мъж има новопотвърдена ХИВ инфекция; не е започнал антиретровирусна терапия и вирусният му товар не е потиснат. Той моли лекаря си да не казва на съпругата му, която също е негова пациентка. Отказва да използва презервативи „засега“.

Теория	Въпросът, който ни кара да зададем
Консеквенциализъм	Какви са вероятните вреди за съпругата и за бъдещото лечение на пациента? Какво става с общественото доверие, ако лекарите разкриват лесно — или никога?
Деонтология	Какво задължение за опазване на медицинската тайна е поето? Има ли съпругата право да не бъде излагана на сериозна вреда? Използва ли се някой само като средство?
Етика на добродетелите	Какво би направил честен, смел и състрадателен лекар — и как би опитал първо да убеди пациента?
Етика на грижата	Кои отношения са застрашени и как да бъдат защитени — консултиране, време, подкрепа пациентът сам да сподели?

Българските правила за медицинската тайна и нейните граници са тема на упражнение 3.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Морал, етика, право и деонтология
2. Етични теории
3. **Принципализъм и критиките му**
4. От Хипократ до Овиедо
5. Българската нормативна рамка
6. Как да анализираме етичен казус

Принципализъм: четири принципа от средно ниво

Уважение към автономността

зачитане на информираните, доброволни решения на хората, способни да ги вземат; подкрепа за онези с ограничена способност

Благодеяние

действие в полза на пациента; претегляне на ползи, рискове и разходи спрямо собствените му цели

Ненанасяне на вреда

без ненужна или несъразмерна вреда (*primum non nocere*); вредата трябва да е оправдана от очакваната полза

Справедливост

справедливо разпределение на ползи, рискове и разходи; еднакви случаи — еднакво; без дискриминация

Т. Л. Бийчамп и Дж. Ф. Чилдрес, **Principles of Biomedical Ethics** (1-во изд. 1979; 8-мо изд. 2019). Принципите са **prima facie** — задължаващи, но не абсолютни („на пръв поглед“): всеки задължава, освен ако в конкретния случай не влезе в конфликт с равно или по-силно задължение. Те не са предварително подредени по важност.

Конкретизиране — стесняване на принципа за даден контекст: „уважението към автономността включва правото на пълнолетен със способност за решение да откаже животоподдържащо лечение“.

Претегляне — кое задължение тежи повече тук; нарушаването трябва да е необходимо, минимално и открито обосновано.

Какво изискват принципите — и какво не означават

Принцип	Изисква	Не означава
Автономност	информация, разбиране, доброволност, способност **за това решение**; зачитане на отказа	че пациентът може да поиска всяко лечение; че диагнозата сама по себе си отнема способността
Благодеяние	активно действие: лечение, профилактика, спасяване, облекчаване; баланс между полза и тежест	да се реши **вместо** способен пациент какво е добро за него (твърд патернализъм)
Ненанасяне на вреда	дължима грижа; без ненужен риск; съразмерност на риска и ползата	избягване на всеки риск — няма ефективно лечение без риск
Справедливост	без дискриминация; справедливи процедури за оскъдни ресурси; внимание към най-уязвимите	еднакво лечение за всички независимо от нуждата

Мекият патернализъм защитава човек, за чийто конкретен избор оценката показва, че не е автономен (напр. при делир); **твърдият** патернализъм пренебрегва автономен избор и изисква изключителна обосновка. Оценка на способността: упражнение 2.

Справедливост: как да се разпределят здравните грижи?

Теория	Критерий за справедливо разпределение
Егалитарна (Дж. Ролс)	справедливо равенство на възможностите; неравенства само ако са в полза на най-неравностойните
Утилитарна	максимален здравен резултат за вложения ресурс (напр. години живот, коригирани спрямо качеството, QALY)
Либертарианска (Р. Нозик)	права чрез справедливо придобиване и доброволно прехвърляне; няма общо право на преразпределение на здравни грижи
Комунитарна	общите ценности на общността определят какво се дължи

Учебна класификация (учебник по медицинска етика)

1. съразмерност според статуса (исторически)
2. социална справедливост — основни блага за всички
3. утилитарно максимизиране
4. гарантиран минимум, след това разпределение според приноса
5. съвършената справедливост като идеал, към който се стремим

> *Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.*
>
> — Конституция на Република България, чл. 52, ал. 1

Критики към принципализма

Няма метод за конфликтите

Клаузър и Герт (1990): принципите са „заглавия на глави“ — напомнят ни теми, но не казват какво да правим при сблъсък; претеглянето може да прикрие интуицията.

Европейска алтернатива

Рентдорф (2002), Барселонска декларация (1998): **автономност, достойнство, интегритет, уязвимост** — по-релационни и по-близки до европейското право (Овиедо, чл. 1: достойнство и идентичност на човешкия индивид).

Защита и усъвършенстване

Гилън (1994; 2003): четири принципа **плюс внимание към обхвата** — към кого имаме тези задължения? — като автономността е „първа сред равни“.

Релационна и културна критика

Етиката на грижата и на добродетелите: принципите пренебрегват отношенията и характера. В семейно ориентираните култури решенията често се **споделят** — но споделянето на решението не означава то да бъде отнето от пациента.

Clouser & Gert, J Med Philos 1990;15:219–236 · Gillon, BMJ 1994;309:184 · Gillon, J Med Ethics 2003;29:307–312 · Rendtorff, Med Health Care Philos 2002;5:235–244

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Морал, етика, право и деонтология
2. Етични теории
3. Принципализъм и критиките му
4. **От Хипократ до Овиедо**
5. Българската нормативна рамка
6. Как да анализираме етичен казус

Хипократовата традиция: трайно ядро, ясни граници

Хипократовата клетва (ок. IV в. пр.н.е.) задължава лекаря:

- да почита учителя си и да предава изкуството;
- да лекува болните „според силите и разбирането си“ в тяхна полза, никога за вреда;
- да не дава смъртоносно средство и абортивен песар;
- да се въздържа от несправедливост и от интимни връзки с пациентите и домашните им;
- да мълчи за видяното и чутото при лечението.

Primum non nocere е по-късна латинска формула, а не ред от Клетвата.

Какво остава

благодеяние, ненанасяне на вреда, медицинска тайна, професионална почтеност, задължения отвъд личния интерес

Какво липсва

съгласието на пациента — лекарят решава „по своя преценка“; няма идея за справедлив достъп; цехова клетва пред боговете, а не публичен стандарт с отговорност

Преди 1945 г.: от добродетелта на лечителя към кодексите на съсловието

Период	Основно развитие
ок. 1750 г. пр.н.е.	Кодексът на Хамурапи: възнаграждението и наказанието на лечителя зависят от резултата и общественото положение на пациента
IV в. пр.н.е.	Хипократовата клетва и Корпус: полза, ненанасяне на вреда, тайна
IV–X в.	християнски болници (Василий Велики, Кесария); византийски и ислямски болници; ал-Рухауи, *Етика на лекаря*
1803	Томас Пърсивал, *Medical Ethics* — задължения в болницата, към колегите и обществото; основа на първия Кодекс на AMA (1847)
1846–1864	публичната демонстрация на етерна анестезия (1846) ускорява разпространението ѝ и облекчаването на страданието става постижимо задължение; Червеният кръст (1863) и Първата женевска конвенция (1864): помощ за ранените от всяка страна
1901	първият събор на българските лекари — учредяване на Българския лекарски съюз

Нюрнберг: повратната точка

Нюрнбергският лекарски процес (декември 1946 – август 1947): 23 подсъдими, 20 от тях лекари; 16 осъдени, 7 — на смърт. Престъпления: смъртоносни опити върху затворници (хипотермия, голяма височина, инфекции, стерилизация) и убийства на хора с увреждания.

В присъдата са формулирани **десет принципа** — **Нюрнбергският кодекс** (1947).

> *Доброволното съгласие на човека, върху когото се провежда опитът, е абсолютно необходимо.*
>
> — Нюрнбергски кодекс, принцип 1

Други принципи: научна необходимост, предварителни опити с животни, избягване на ненужно страдание, риск, съразмерен на ползата, квалифицирани изследователи, **свобода за оттегляне**.

Злоупотребите не спират през 1945 г.

Проучването в Тъскиги, САЩ (1932–1972): лечението на сифилис е отказвано на чернокожи мъже, за да се наблюдава болестта. Скандалът води до **Белмонтския доклад** (1979): уважение към личността, благодеяние, справедливост.

Shuster E. Fifty years later: the significance of the Nuremberg Code. N Engl J Med 1997;337:1436–1440

Международни стандарти след 1945 г.

Документ	Година	Какво добавя
Женевска декларация на СМА	1948 / 2017	съвременен лекарски обет; редакцията от 2017 г. добавя **уважение към автономността и достойнството**, споделяне на знанието и грижа за собственото здраве на лекаря
Международен кодекс по медицинска етика на СМА	1949 / 2022	общи задължения към пациентите, колегите и обществото
Хелзинкска декларация на СМА	1964 / 2024	изследвания с хора: етична комисия, информирано съгласие, уязвими групи, плацебо, достъп след проучването
Белмонтски доклад (САЩ)	1979	уважение към личността, благодеяние, справедливост в изследванията
Лисабонска декларация на СМА	1981 / 1995	права на пациента — изрично посочена в българския Кодекс, чл. 10
Конвенция от Овиедо (Съвет на Европа)	1997	първият **задължителен** международен договор в областта на биомедицината

Parsa-Parsi RW. JAMA 2017;318:1971–1972 · WMA Declaration of Helsinki, JAMA 2025;333:71–74

Конвенцията от Овиедо и мястото ѝ в българското право

Конвенция за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината (Съвет на Европа, CETS № 164): открита за подписване 04.04.1997, в сила от 01.12.1999. **България:** подписана 31.05.2001, ратифицирана със закон от 26.02.2003 (ДВ, бр. 21/2003), ратификационният инструмент е депозиран на 23.04.2003; обнародвана ДВ, бр. 32/2005; в сила за България от 01.08.2003.

> *Интересът и благото на човека имат предимство над интереса на обществото или този на науката.*
>
> — Конвенция от Овиедо, чл. 2

> *Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.*
>
> — Конституция на Република България, чл. 5, ал. 4

Основни членове: 1 достойнство · 3 равен достъп · 4 професионални стандарти · 5 съгласие · 6 лица, неспособни да дадат съгласие · 8 спешност · 9 предварително изразени желания · 10 личен живот и информация.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Морал, етика, право и деонтология
2. Етични теории
3. Принципализъм и критиките му
4. От Хипократ до Овиедо
5. **Българската нормативна рамка**
6. Как да анализираме етичен казус

Кои норми обвързват лекаря в България?

Ниво	**Основни актове за лекаря**
Конституция (1991)	човешко достойнство, лична неприкосновеност, личен живот, право на здравна помощ; без медицински опити без доброволно писмено съгласие (чл. 29, ал. 2)
Ратифицирани международни договори	ЕКПЧ; **Конвенцията от Овиедо** — с предимство пред противоречащото им вътрешно право (Конституция, чл. 5, ал. 4)
Закони	**Закон за здравето** (2004): права на пациента, информирано съгласие, изследвания, репродукция; **Закон за лечебните заведения**; **Закон за здравното осигуряване**; **Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина** (ЗСОЛЛДМ, 1998); Наказателен кодекс, Закон за задълженията и договорите (отговорност)
Право на ЕС (отделен правопорядък)	в приложното си поле има предимство пред противоречащото национално право; напр. GDPR (здравни данни, чл. 9), Регламент (ЕС) № 536/2014 за клиничните изпитвания
Подзаконови актове	наредби на министъра на здравеопазването, медицински стандарти
Съсловни норми	**Кодекс за професионална етика на лекарите в България**; правила за добра медицинска практика
Вътрешни правила	правилник на лечебното заведение — подчинен на всички горни нива

Конституцията: три разпоредби, които всеки лекар трябва да познава

> *Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.*
>
> — Конституция на Република България, чл. 29, ал. 2

> *Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.*
>
> — Конституция на Република България, чл. 32, ал. 1

> *Никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки освен в предвидените от закона случаи.*
>
> — Конституция на Република България, чл. 52, ал. 4

Всяка от тях се развива в следващо упражнение: изследвания (упр. 6), медицинска тайна (упр. 3), съгласие и отказ (упр. 2).

Законът за здравето: пациентът като носител на права

> *Пациент е всяко лице, което е потърсило или на което се оказва медицинска помощ.*
>
> — Закон за здравето, чл. 84, ал. 1

> *На пациента се оказва здравна помощ независимо от неговата възраст, пол, произход, език, национална, расова или политическа принадлежност, образование, убеждения, културно равнище, сексуална ориентация, лично, обществено или материално положение, увреждане и вид и причина на заболяването.*
>
> — Закон за здравето, чл. 85

Чл. 86, ал. 1 — избрани права: зачитане на гражданските, политическите, икономическите, социалните, културните и религиозните права; достъпна и качествена здравна помощ; повече от едно медицинско становище; защита на здравните данни; ясна и достъпна информация; сигурност и безопасност на процедурите; предотвратяване на болката и страданието; достъп до медицинската документация.

Чл. 93: жалби до регионалната здравна инспекция, която прави проверка в 7-дневен срок. **Чл. 94:** пациентът е длъжен и да се грижи за здравето си и да не уврежда здравето на другите.

Българският лекарски съюз и съсловното саморегулиране

Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ, 1998):

- всички лекари, които упражняват професията си, членуват в **Българския лекарски съюз** (БЛС) и са вписани в регистъра на районна колегия (чл. 3–4);
- БЛС изготвя **Кодекса за професионална етика** и контролира спазването му (чл. 5, ал. 1, т. 3); приема **правила за добра медицинска практика**, които се утвърждават от министъра на здравеопазването (чл. 5, ал. 1, т. 4);
- жалбите се разглеждат от **комисиите по професионална етика** на районните колегии (чл. 39); наказателното постановление се издава от председателя на управителния съвет на колегията (чл. 40, ал. 3).

> *За нарушения по чл. 37, ал. 1, т. 1 на лекаря ... могат да бъдат налагани следните наказания:*
>
> 1. *порицание;*
> 2. *глоба в размер една до пет минимални работни заплати;*
> 3. *заличаване от регистъра на колегията за срок от 3 месеца до една година.*
>
> — ЗСОЛЛДМ, чл. 38 (съкратено)

Наказанието не отменя търсенето на наказателна, гражданска или дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда (чл. 42, ал. 1). Исторически: БЛС е учреден през 1901 г., закрит през 1949 г., възстановен през 1990 г.; законовата му рамка е създадена с този закон през 1998 г.

Кодекс за професионална етика на лекарите в България

Приет от събора на БЛС и обнародван в „Държавен вестник“ (бр. 79/2000, изм. и доп. бр. 85/2013); **задължителен за всеки лекар**.

Ценности (чл. 2): професионална компетентност и отговорност; честност, човечност, милосърдие; добросъвестност; тактичност; вежливост; психологичен подход към болния; толерантност към религиозните, етническите и политическите убеждения; **еднакво отношение** към болните с различно обществено, социално и материално положение.

> *Независимо от своята специалност, квалификация или ангажименти, лекарят е длъжен да оказва спешна помощ на всеки болен, чието здраве и живот се намират в непосредствена опасност.*
>
> — Кодекс за професионална етика, чл. 11

Чл.	Правило (съкратено)
10	признава правата на пациентите, посочени в Лисабонската декларация на CMA (1981)
12	може да откаже лечение при липса на доверие — не и при спешни случаи; може да откаже при пряка заплаха за здравето и живота си (ал. 2)
26	без процедури без съгласие освен при непосредствена заплаха за живота — да се чете с чл. 87–90 от Закона за здравето: съгласие дават лицата, посочени в закона, а изключението изисква законовите предпоставки (чл. 89, ал. 2)
28	право на информация и на второ мнение
29	при отказ лекарят разяснява неблагоприятната прогноза без лечение — освен ако пациентът не желае тази информация
30	лекарят няма право да прекъсва живота на пациента
32	може да откаже по убеждения прекъсване на нормална бременност

Едно поведение — различни видове отговорност

Дисциплинарна

към работодателя, по Кодекса на труда

Административна

вкл. съсловни санкции: порицание, глоба, заличаване от регистъра на БЛС (ЗСОЛЛДМ, чл. 37–42); жалби и проверка от РЗИ (Закон за здравето, чл. 93), наказания по съответния санкционен състав

Наказателна

напр. причиняване по непредпазливост на телесна повреда или смърт при упражняване на професия (Наказателен кодекс)

Гражданска

обезщетение за пациента: договорна или деликтна (Закон за задълженията и договорите)

Етиката не е само „мека“: в България ядрото на медицинската етика е кодифицирано и нарушението му има правни последици. Но спазването на правния минимум не прави лекаря добър лекар.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Морал, етика, право и деонтология
2. Етични теории
3. Принципализъм и критиките му
4. От Хипократ до Овиедо
5. Българската нормативна рамка
6. **Как да анализираме етичен казус**

Структуриран метод в осем стъпки

1. **Факти** — медицински (диагноза, прогноза, възможности, несигурност), ценностите на пациента, контекстът, конфликтите на интереси и приложимото право.
2. **Етичният въпрос** — формулиран от позицията на този, който взема решението.
3. **Заинтересовани страни** — пациент, семейство, екип, други пациенти, общество.
4. **Принципи и задължения** — кои са в напрежение и защо?
5. **Възможности** — повече от две: компромис, ограничено във времето лечение, второ мнение, етична консултация.
6. **Претегляне** — ползи, вреди, справедливост, законосъобразност на всяка възможност.
7. **Решение и обосновка** — доводите, които правят една възможност по-тежка.
8. **Съобщаване и преглед** — как да се каже на пациента и семейството; какво би променило решението.

Три чести грешки

етиката като аритметика · един принцип автоматично печели („капанът на автономността“ или „капанът на патернализма“) · смесване на „законно“ с „етично“

Методът на четирите полета (Jonsen, Siegler & Winslade)

1 · Медицински показания (благодеяние, ненанасяне на вреда)

диагноза и прогноза; цели на лечението; вероятност за успех; план при неуспех

2 · Предпочитания на пациента (автономност)

информиран ли е и разбира ли? Способност за решение? По-ранни желания? Кой решава, ако той не може?

3 · Качество на живот

очаквано функциониране, симптоми и благополучие, оценени заедно с пациента; пристрастия на оценяващия

4 · Контекстуални фактори (справедливост, право)

семейство, финанси, религия, ресурси, право, конфликти на интереси на лекарите

И двата метода водят до едно: етически защитимо решение, отчитащо всички засегнати, което може да бъде **обяснено публично**. Помощ: клинична етична консултация или комисия с такава функция, ако е налична в лечебното заведение; правен съвет.

Решен пример: пълнолетен отказва кръвопреливане

Казус

42-годишен Свидетел на Йехова със способност за вземане на решение кърви след операция. Отказва кръв и кръвни продукти, информиран за риска от смърт; съпругата му го подкрепя.

	Автономност	**Благодеяние**	**Ненанасяне на вреда**	**Справедливост**
Пациент	информиран, доброволен, повторен отказ	грижа в съгласие с ценностите му	знае риска от смърт	еднакво уважение и усилие
Лекар	проверява способността, липсата на натиск, документира	използва клинично показаните и приети от пациента възможности	избягва нежелана намеса в тялото	не оттегля грижата заради отказа
Семейство	зачита решението му	иска той да оцелее	страхува се да го загуби	изслушано, но не решава вместо него

Примерен извод: пълнолетен със способност за решение може да откаже по всяко време (Закон за здравето, чл. 90, ал. 1); отказът се удостоверява с подписи (ал. 2); екипът използва клинично показаните и индивидуално приети от пациента възможности и не го изоставя. Ясният, конкретен и актуален отказ на способен пациент изисква защита — спешността сама по себе си не отменя автономността (ЕСПЧ, Pindo Mulla с/у Испания [GC], 17.09.2024). Когато отказът и заплахата за живота съвпаднат, **ръководителят на лечебното заведение** може да вземе решение за животоспасяващо лечение (чл. 90, ал. 4) — различна ситуация от пациента, който **не може** да даде съгласие (чл. 89, ал. 2). Как се съотнася тази възможност с отказа на способен пациент и с чл. 5 от Конвенцията от Овиедо — в упражнение 2.

Казус 1 · „Не казвайте на майка ми“

Казусът

75-годишна жена има доброкачествена, но сложна формация в корема, която налага операция. Синът ѝ моли личния лекар да не ѝ казва: тя е много тревожна, имала е панически пристъпи, а „в нашето семейство децата поемат тежките новини“. Пациентката има доверие на сина си, но винаги е очаквала лекарят ѝ да говори пряко с нея.

1. Чие е правото да реши колко да знае пациентката — нейно или на сина ѝ?
2. Как би подходил към молбата на сина привърженикът на деонтологията и този на етиката на грижата?
3. Къде е границата между състрадателното, поетапно съобщаване и измамата?
4. Какво казва българското право за правото на пациента на информация и за правото му да откаже да бъде информиран?

Казус 2 · Последното легло в интензивното отделение

Казусът

По време на тежък грипен сезон остава едно легло в интензивното отделение. Пациент А, 82 г., има напреднала ХОББ; пациент Б, 45 г., досега здрав, баща на три деца, има тежка постгрипна пневмония. При интензивно лечение очакваната (хипотетична) вероятност за преживяване до изписването е 30% за А и 80% за Б; без него и двамата вероятно ще починат. Пациент А е пристигнал десет минути по-рано.

1. Кои критерии на справедливост са относими: нужда, очаквана полза, възраст, „социална стойност“, ред на пристигане?
2. Как биха решили утилитаристът и деонтологът — и какво би пропуснал всеки от тях?
3. Справедливо ли е възрастта или очакваното качество на живот да са критерий, или това е дискриминация?
4. Какво дължат болницата и лекарят на пациента, който не получава леглото?

Казус 3 · Двойна доза без установена вреда

Казусът

Млад лекар забелязва, че началникът му е назначил двойна от препоръчителната доза венозен антибиотик; вече са поставени две дози. Бъбречната функция е нормална, пациентката няма оплаквания и възстановяването ѝ изглежда незасегнато. Началникът казва: „Нищо лошо не е станало. Не го записвай и не казвай на пациентката — само ще я притесниш и ще си навлечем жалба.“

1. Кои принципи и кои професионални добродетели са засегнати?
2. Има ли задължение да се съобщи на пациента за грешка, която не е причинила вреда?
3. Оправдава ли йерархията младия лекар, ако премълчи?
4. Какво трябва да направи сега — клинично (корекция, оценка, наблюдение) и по кои канали?

Обобщение

Понятия и теории

1. Етиката е критична рефлексия върху морала; правото поставя задължителни изисквания, които етиката може да подкрепя, надхвърля или критикува. Медицинската деонтология е учението за професионалния дълг.
2. Консеквенциализмът, деонтологията, етиката на добродетелите и на грижата разкриват различни морално значими страни.
3. Четирите принципа са **prima facie**: трябва да се конкретизират и открито да се претеглят.

История и право

1. Нюрнберг поставя **доброволното съгласие** в основата; Женева, Хелзинки и Лисабон го развиват; Овиедо създава задължителни договорни задължения за страните.
2. В България Конституцията, Конвенцията от Овиедо, Законът за здравето и Кодексът за професионална етика обвързват всеки лекар; БЛС следи за спазването на Кодекса.
3. Доброто решение следва метод и може да бъде обосновано публично.

Следващото упражнение: информирано съгласие — чл. 87–92 от Закона за здравето в детайли и дванадесет казуса.

Благодаря за вниманието!